

Question 1

Terminé

Noté sur 1,00

L'exacerbation sévère d'asthme est caractérisée par un ou plusieurs des éléments suivants :

- a. Une fréquence respiratoire > 30 cycles par minute.
- b. Un DEP > 50% de la valeur théorique.
- c. Une agitation.
- d. Un pouls entre 100 et 120 battements par minute.
- e. Des signes de lutte marqués.

Les réponses correctes sont : Une fréquence respiratoire > 30 cycles par minute., Une agitation., Des signes de lutte marqués.

Question 2

Terminé

Noté sur 1,00

Une contamination par le BK peut avoir pour origine(s) :

- a. Le sol des étables
- b. L'eau de boisson
- c. Le lait de vache
- d. L'expectoration d'un tuberculeux pulmonaire
- e. Les urines d'un tuberculeux pulmonaire

La réponse correcte est : L'expectoration d'un tuberculeux pulmonaire



Question 3

Terminé

Noté sur 1,00

Parmi les symptômes suivants, lesquels sont en faveur de la maladie asthmatique? :

- a. Une bronchorrhée.
- b. Une toux.
- c. Des sifflements.
- d. Une hémoptysie.
- e. Une dyspnée.

Les réponses correctes sont : Une toux., Des sifflements., Une dyspnée.

Question 4

Terminé

Noté sur 1,00

La mise en place d'un filtre cave chez un patient présentant une embolie pulmonaire est indiquée :

- a. En cas de récurrence de l'embolie pulmonaire sous traitement anticoagulant
- b. En cas de thrombose veineuse des membres supérieurs
- c. En cas de thrombose veineuse proximale
- d. En cas de contre-indication au traitement anti-coagulant
- e. En cas de thrombose veineuse cérébrale

Les réponses correctes sont : En cas de récurrence de l'embolie pulmonaire sous traitement anticoagulant, En cas de contre-indication au traitement anti-coagulant

Question 5

Non répondue

Noté sur 1,00

Le traitement anticoagulant par Rivaroxaban :

- a. Nécessite une phase de chevauchement avec le Sintrom
- b. Est contre-indiqué en association avec les AINS
- c. Peut être prescrit en première intention en cas d'embolie pulmonaire sans signe de gravité
- d. Peut être prescrit chez la femme enceinte
- e. Nécessite un contrôle de la créatinine plasmatique avant d'initier le traitement

Les réponses correctes sont : Peut être prescrit en première intention en cas d'embolie pulmonaire sans signe de gravité, Nécessite un contrôle de la créatinine plasmatique avant d'initier le traitement



Question 6

Terminé

Noté sur 1,00

Concernant le diagnostic étiologique de l'ictère, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) ?

- a. Un bilan hépatique complet et une numération formule sanguine sont demandés en première intention
- b. L'échographie abdominale est l'examen morphologique de première intention devant une cholestase
- c. La dilatation des voies biliaires intra-hépatiques définit la cholestase extra-hépatique
- d. Des sérologies virales devraient être demandées devant une cholestase intra-hépatique
- e. La ponction biopsie hépatique est indiquée dans certains cas de cholestase extra-hépatique

Les réponses correctes sont : Un bilan hépatique complet et une numération formule sanguine sont demandés en première intention, L'échographie abdominale est l'examen morphologique de première intention devant une cholestase, La dilatation des voies biliaires intra-hépatiques définit la cholestase extra-hépatique, Des sérologies virales devraient être demandées devant une cholestase intra-hépatique

Question 7

Terminé

Noté sur 1,00

Quel (s) signe (s) clinique (s) évoque (nt) une angiocholite aigue ?

- a. Splénomégalie
- b. Fièvre
- c. Douleur de l'hypocondre droit
- d. Ictère
- e. Signe de Murphy

Les réponses correctes sont : Fièvre, Douleur de l'hypocondre droit, Ictère

Question 8

Terminé

Noté sur 1,00

Quels sont parmi les étiologies suivantes celles qui se manifestent par un œil rouge et douloureux :

- a. Un glaucome primitif à angle ouvert avec une pression intra-oculaire à 25mmHg
- b. Une conjonctivite virale à adénovirus
- c. Une kératite aiguë bactérienne
- d. Une uvéite antérieure aiguë
- e. Une épisclérite

Les réponses correctes sont : Une kératite aiguë bactérienne, Une uvéite antérieure aiguë, Une épisclérite



Question 9

Terminé

Noté sur 1,00

Au cours de l'embolie pulmonaire, les signes électrocardiographiques qui peuvent s'observer sont :

- a. La fibrillation atriale
- b. Le flutter atrial
- c. Un bloc de branche droit complet
- d. Une ischémie sous épocardique dans le territoire antéro-septal
- e. Une lésion sous-épocardique dans le territoire antéro-septal

Les réponses correctes sont : La fibrillation atriale, Le flutter atrial, Un bloc de branche droit complet, Une ischémie sous épocardique dans le territoire antéro-septal

Question 10

Terminé

Noté sur 1,00

Le pyrazinamide :

- a. Peut avoir une toxicité hépatique
- b. A une toxicité neurologique
- c. A une activité bactéricide à l'égard du bacille de Koch
- d. A une action sur les mycobactéries intracellulaires
- e. Est responsable d'une hyperuricémie

Les réponses correctes sont : Peut avoir une toxicité hépatique, A une activité bactéricide à l'égard du bacille de Koch, A une action sur les mycobactéries intracellulaires, Est responsable d'une hyperuricémie

Question 11

Terminé

Noté sur 1,00

Le bilan initial d'asthme comporte? :

- a. Une numération formule sanguine.
- b. Une spirométrie avec un test de bronchodilatation.
- c. Des tests cutanés.
- d. Un scanner thoracique.
- e. Un dosage des immunoglobulines spécifiques

Les réponses correctes sont : Une spirométrie avec un test de bronchodilatation., Des tests cutanés.



Question 12

Terminé

Noté sur 1,00

En cas de suspicion de dissection de l'aorte ascendante :

- a. L'échocardiographie transthoracique peut objectiver la porte d'entrée
- b. La réalisation d'une échocardiographie transoesophagienne est systématique
- c. Les D-dimères positifs confirment le diagnostic
- d. L'hypertension artérielle doit être tolérée pour maintenir la perfusion des organes cibles
- e. L'ECG peut montrer des signes en faveur d'un syndrome coronarien aigu

Les réponses correctes sont : L'échocardiographie transthoracique peut objectiver la porte d'entrée, L'ECG peut montrer des signes en faveur d'un syndrome coronarien aigu

Question 13

Terminé

Noté sur 1,00

Quelle(s) complications(s) peut-on attribuer à l'isoniazide au cours d'un traitement antituberculeux ?

- a. Dyschromatopsie
- b. Troubles cochléo-vestibulaires
- c. Polynévrite des membres inférieurs
- d. Inefficacité d'une pilule contraceptive minidosée
- e. Hépatite avec augmentation des transaminases

Les réponses correctes sont : Polynévrite des membres inférieurs, Hépatite avec augmentation des transaminases

Question 14

Terminé

Noté sur 1,00

Concernant l'évolution de la schizophrénie :

- a. Après une rechute délirante traitée, les patients retrouvent leur niveau de fonctionnement initial
- b. Le début tardif de la maladie est un facteur de mauvais pronostic
- c. Le sexe féminin est de meilleur pronostic
- d. La Durée de psychose non traitée est déterminante pour le pronostic
- e. Les symptômes résiduels sont possibles entre les rechutes

Les réponses correctes sont : Le sexe féminin est de meilleur pronostic, La Durée de psychose non traitée est déterminante pour le pronostic, Les symptômes résiduels sont possibles entre les rechutes



Question 15

Terminé

Noté sur 1,00

Les examens biologiques utiles pour évaluer le retentissement d'une diarrhée chronique sécrétoire :

- a. Ionogramme sanguin
- b. Le dosage de la CRP
- c. La cholestérolémie
- d. fonction rénale (urée et creat)
- e. la gazométrie sanguine

Les réponses correctes sont : Ionogramme sanguin, fonction rénale (urée et creat), la gazométrie sanguine

Question 16

Terminé

Noté sur 1,00

Les vomissements au cours d'une occlusion colique par obstruction :

Propositions :

- a. Sont tardifs
- b. Sont fécaloïdes
- c. Soulagent les douleurs abdominales
- d. Entraînent une diminution du météorisme abdominal
- e. Peuvent être absents

Les réponses correctes sont : Sont tardifs, Peuvent être absents

Question 17

Terminé

Noté sur 1,00

Dans la schizophrénie :

- a. La baisse des performances cognitives peut se voir dès la phase prodromale
- b. Une anhédonie peut refléter un syndrome négatif
- c. Le syndrome de désorganisation est pathognomonique de la schizophrénie
- d. Le délire est accessible à la contestation par les faits
- e. Des hallucinations visuelles élémentaires sont possibles

Les réponses correctes sont : La baisse des performances cognitives peut se voir dès la phase prodromale, Une anhédonie peut refléter un syndrome négatif, Des hallucinations visuelles élémentaires sont possibles



Question 18

Terminé

Noté sur 1,00

Le trouble anxiété de séparation est :

- a. Le trouble anxieux le plus fréquent chez l'enfant prépubère
- b. Un trouble qui s'amende spontanément avec la croissance de l'enfant
- c. Un trouble qui touche 4% de la population générale
- d. Défini par une anxiété excessive et inappropriée au regard du stade du développement de l'enfant
- e. Caractérisé par une durée d'évolution des symptômes d'au moins deux semaines

Les réponses correctes sont : Le trouble anxieux le plus fréquent chez l'enfant prépubère, Un trouble qui touche 4% de la population générale, Défini par une anxiété excessive et inappropriée au regard du stade du développement de l'enfant

Question 19

Terminé

Noté sur 1,00

Les symptômes d'un épisode hypomaniaque, selon le DSM-5 :

- a. Comprennent une fuite des idées
- b. Comprennent une réduction des besoins du sommeil
- c. Doivent durer au moins 15 jours
- d. Sont manifestes pour les autres
- e. Entraînent une altération marquée du fonctionnement

Les réponses correctes sont : Comprennent une fuite des idées, Comprennent une réduction des besoins du sommeil, Sont manifestes pour les autres



Question 20

Terminé

Noté sur 1,00

Les thromboses veineuses cérébrales :

- a. Représentent l'étiologie la plus fréquente des AVC chez les sujets âgés
- b. Sont à évoquer devant des céphalées du post partum
- c. Représentent moins de 10% de tous les AVC
- d. Peuvent compliquer des interventions neurochirurgicales
- e. Sont systématiquement associées à un trouble de l'hémostase biologique

Les réponses correctes sont : Sont à évoquer devant des céphalées du post partum, Représentent moins de 10% de tous les AVC

Question 21

Terminé

Noté sur 1,00

Concernant l'angioplastie primaire :

- a. Le délai organisationnel recommandé doit être <60 minutes lorsque le centre dispose d'une salle de cathétérisme cardiaque
- b. L'administration de clopidogrel à la dose de 600 mg est recommandée en amont de l'angioplastie
- c. L'administration d'un bolus d'enoxaparine de 0,5 mg/Kg est recommandée par voie sous-cutanée
- d. La voie radiale doit être privilégiée
- e. Constitue l'attitude thérapeutique de choix par rapport à la thrombolyse en cas d'antécédents d'accident vasculaire cérébral transitoire datant de 3 mois

Les réponses correctes sont : Le délai organisationnel recommandé doit être <60 minutes lorsque le centre dispose d'une salle de cathétérisme cardiaque, L'administration de clopidogrel à la dose de 600 mg est recommandée en amont de l'angioplastie, La voie radiale doit être privilégiée, Constitue l'attitude thérapeutique de choix par rapport à la thrombolyse en cas d'antécédents d'accident vasculaire cérébral transitoire datant de 3 mois



Question 22

Terminé

Noté sur 1,00

L'aire de Broca:

- a. Est situé au niveau au niveau de la 3ème circonvolution frontale
- b. Est touché en cas d'AVC dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche
- c. Est la zone associée à la production des mots parlés
- d. Est situé au niveau de l'hémisphère dominant
- e. Est la zone associée à une aphasie fluente en cas d'AVC ischémique

Les réponses correctes sont : Est situé au niveau au niveau de la 3ème circonvolution frontale, Est la zone associée à la production des mots parlés, Est situé au niveau de l'hémisphère dominant

Question 23

Terminé

Noté sur 1,00

Est(sont) compatible(s) avec un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST :

- a. Une lésion sous-endocardique
- b. Un électrocardiogramme normal
- c. Un sus-décalage transitoire du segment ST
- d. Un bloc de branche gauche complet associé à une douleur thoracique continue évoluant depuis 2 heures
- e. Des ondes T négatives

Les réponses correctes sont : Une lésion sous-endocardique, Un électrocardiogramme normal, Un sus-décalage transitoire du segment ST, Des ondes T négatives



Question 24

Terminé

Noté sur 1,00

L'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST compliqué d'extension au ventricule droit :

- a. Complique souvent l'infarctus de localisation antérieure
- b. L'électrocardiogramme standard des 12 dérivations est suffisant pour en poser le diagnostic
- c. Peut s'associer à un état de choc
- d. Contre-indique l'administration de dérivés nitrés en perfusion veineuse continue
- e. La présence de turgescence des veines jugulaires indique l'administration d'un traitement diurétique pour baisser la pré-charge

Les réponses correctes sont : Peut s'associer à un état de choc, Contre-indique l'administration de dérivés nitrés en perfusion veineuse continue

Question 25

Terminé

Noté sur 1,00

A propos du retard de croissance intra-utérin dans la prééclampsie, les propositions justes sont :

- ☐ a. Il est dit sévère lorsque le poids fœtal estimé échographiquement est inférieur au 3ème percentile
- b. Quelle qu'en soit sa sévérité, il constitue un élément de gravité de la prééclampsie
- c. Son association à l'oligoamnios est évocatrice de l'origine vasculaire
- d. La présence d'un reverse flow au doppler ombilical constitue une indication à l'extraction fœtale
- e. Est la conséquence d'une hypoperfusion placentaire

Les réponses correctes sont : Il est dit sévère lorsque le poids fœtal estimé échographiquement est inférieur au 3ème percentile, Son association à l'oligoamnios est évocatrice de l'origine vasculaire, La présence d'un reverse flow au doppler ombilical constitue une indication à l'extraction fœtale, Est la conséquence d'une hypoperfusion placentaire



Question 26

Terminé

Noté sur 1,00

Au niveau des bronches, les mécanorécepteurs :

- a. Sont localisés uniquement au niveau de muscle lisse bronchique
- b. Sont localisées au niveau de l'épithélium bronchique
- c. Sont des récepteurs à adaptation rapide
- d. Détectent le changement de la tension du muscle lisse bronchique
- e. Stimulés entraînent une contraction du muscle lisse bronchique

Les réponses correctes sont : Sont localisés uniquement au niveau de muscle lisse bronchique, Détectent le changement de la tension du muscle lisse bronchique

Question 27

Terminé

Noté sur 1,00

La compliance pulmonaire :

- a. Correspond à la relation entre le volume et la pression pulmonaires
- b. Est maximale à la Capacité Pulmonaire Totale (CPT)
- c. Est améliorée par la présence du surfactant
- d. Est augmentée en cas de fibrose pulmonaire
- e. Est diminuée en cas de pneumopathie infectieuse aigue

Les réponses correctes sont : Correspond à la relation entre le volume et la pression pulmonaires, Est améliorée par la présence du surfactant, Est diminuée en cas de pneumopathie infectieuse aigue

Question 28

Terminé

Noté sur 1,00

Quels sont les facteurs de mauvais pronostic en cas de péritonite aigue généralisée:

- a. La survenue chez un sujet sur corticothérapie au long cours
- b. L'existence d'une perforation colique
- c. L'origine appendiculaire
- d. L'existence d'un œdème aigue du poumon sur la radiographie du thorax
- e. La présence d'une hyperleucocytose à 15000

Les réponses correctes sont : La survenue chez un sujet sur corticothérapie au long cours, L'existence d'une perforation colique, L'existence d'un œdème aigue du poumon sur la radiographie du thorax



Question 29

Terminé

Noté sur 1,00

La prise en charge de première intention d'une dépression à l'adolescence comporte:

- a. Un inhibiteur de recapture de la sérotonine
- b. Une psychothérapie
- c. Un thymorégulateur
- d. Des benzodiazépines
- e. Une guidance familiale

Les réponses correctes sont : Une psychothérapie, Une guidance familiale

Question 30

Terminé

Noté sur 1,00

La crise d'hypertonie aiguë par fermeture de l'angle est une séquence de plusieurs mécanismes, indiquer le ou le(s) mécanismes corrects

- a. La pression au niveau de la chambre antérieure de l'œil est plus élevée que celle de la chambre postérieure
- b. Un blocage pupillaire
- c. L'humeur aqueuse ne passe plus dans la chambre antérieure
- d. L'angle irido-cornéen est fermé par la cornée
- e. Il existe une hypertonie oculaire sévère

Les réponses correctes sont : Un blocage pupillaire, L'humeur aqueuse ne passe plus dans la chambre antérieure, Il existe une hypertonie oculaire sévère



Question 31

Terminé

Noté sur 1,00

Les métrorragies fonctionnelles :

- a. Sont des hémorragies génitales basses
- b. Sont la cause la plus fréquente d'hémorragies génitales chez les âges extrêmes
- c. Sont due à une hyper-progesteronémie relative
- d. Répondent favorablement à un traitement médical
- e. Sont un diagnostic d'élimination

Les réponses correctes sont : Sont la cause la plus fréquente d'hémorragies génitales chez les âges extrêmes, Répondent favorablement à un traitement médical, Sont un diagnostic d'élimination

Question 32

Terminé

Noté sur 1,00

Les images évocatrices de cancer broncho-pulmonaire à la radiographie du thorax sont :

- a. Opacité non systématisée rétractile
- b. Opacité arrondie intra-parenchymateuse à contours polylobés
- c. Image cavitaire dont les parois sont fines et les limites internes régulières
- d. Opacité périphérique au niveau du champ pulmonaire dont l'angle de raccordement est obtu avec la paroi thoracique
- e. Hyper clarté localisée en rapport avec un emphysème obstructif

Les réponses correctes sont : Opacité non systématisée rétractile, Opacité arrondie intra-parenchymateuse à contours polylobés, Hyper clarté localisée en rapport avec un emphysème obstructif



Question 33

Terminé

Noté sur 1,00

Dans le contexte d'un carcinome non à petites cellules du poumon gauche, parmi les signes cliniques suivants,

quel est l'élément qui serait en faveur d'un envahissement médiastinal :

- a. Toux rebelle
- b. Hémoptysies minimales mais répétées
- c. Hippocratisme digital
- d. Voix bitonale
- e. Aucun signe

La réponse correcte est : Voix bitonale

Question 34

Terminé

Noté sur 1,00

L'épiglottite :

- a. Est souvent nocturne
- b. S'exprime cliniquement par une dysphagie
- c. Récidive fréquemment
- d. Nécessite souvent une trachéotomie
- e. Est une indication aux CG3

Les réponses correctes sont : S'exprime cliniquement par une dysphagie, Est une indication aux CG3



Question 35

Terminé

Noté sur 1,00

Concernant la vaccination contre le VHB :

- a. Est obligatoire chez les tous les nouveaux nés quelque soit le statut Ag HBs de la mère
- b. N'est obligatoire que chez les nouveaux nés de mère Ag HBs (+) ayant une forte charge virale
- c. Est obligatoire chez les hémodialysés dépistés Ag HBs (-)
- d. Le vaccin est un Ag HBs obtenu par recombinaison génétique
- e. Le vaccin est administré par voie intra musculaire

Les réponses correctes sont : Est obligatoire chez les tous les nouveaux nés quelque soit le statut Ag HBs de la mère, Est obligatoire chez les hémodialysés dépistés Ag HBs (-), Le vaccin est un Ag HBs obtenu par recombinaison génétique, Le vaccin est administré par voie intra musculaire

Question 36

Terminé

Noté sur 1,00

L'hépatite aigue virale dans sa forme ictérique commune se manifeste cliniquement par :

- a. Un syndrome pseudo grippal qui précède l'apparition de l'ictère
- b. L'apparition à la phase ictérique d'un ictère avec des selles décolorées
- c. L'existence à l'examen physique d'une atrophie hépatique
- d. Splénomégalie dans 25% des cas
- e. Une désorientation temporo-spatiale fréquemment associée à l'ictère

Les réponses correctes sont : Un syndrome pseudo grippal qui précède l'apparition de l'ictère, Splénomégalie dans 25% des cas



Question 37

Terminé

Noté sur 1,00

Chez une femme âgée de 50 ans qui consulte pour hémorragie génitale haute :

- a. Les métrorragies fonctionnelles sont la cause la plus fréquente
- b. L'exocervicite est une cause potentielle
- c. L'hystéroscopie doit être réalisée
- d. Une biopsie du col est systématique
- e. Le traitement hormonal substitutif doit être envisagé

Les réponses correctes sont : Les métrorragies fonctionnelles sont la cause la plus fréquente, L'hystéroscopie doit être réalisée

Question 38

Terminé

Noté sur 1,00

Quelle(s) affirmation(s) est(sont) exacte(s) concernant l'angine herpétique ? :

- a. La durée de l'incubation de la maladie est de 15 jours
- b. Elle est responsable d'une angine aigue érythémateuse
- c. Le début est brutal
- d. Elle est due à l'Herpes virus type 2
- e. Les vésicules sont limitées

La réponse correcte est : Le début est brutal

Question 39

Terminé

Noté sur 1,00

Quel (s) geste (s) peut-on réaliser pour traiter une lithiase de la voie biliaire principale ?

- a. Echo-endoscopie
- b. Cholangiographie peropératoire
- c. Cholécotomie
- d. Bili-IRM
- e. CPRE

Les réponses correctes sont : Cholécotomie, CPRE



Question 40

Terminé

Noté sur 1,00

La rupture du kyste hydatique du poumon dans les bronches :

- a. Est un évènement rare.
- b. Elle peut passer inaperçue.
- c. Elle peut être responsable d'un état de choc anaphylactique.
- d. Elle peut engendrer une hémoptysie cataclysmique.
- e. Elle va être suivie par la guérison du kyste.

Les réponses correctes sont : Elle peut passer inaperçue., Elle peut être responsable d'un état de choc anaphylactique., Elle peut engendrer une hémoptysie cataclysmique.

Question 41

Terminé

Noté sur 1,00

Quelles sont les affirmations justes concernant les sinusites maxillaires à *Aspergillus Fumigatus* ? :

- a. Elle est le plus souvent unilatérale
- b. Le point de départ est souvent d'origine dentaire
- c. Une cacosmie est souvent associée
- d. Le scanner du massif facial peut montrer un aspect de « balle » calcique
- e. Le traitement repose sur l'administration d'un antimycosique

Les réponses correctes sont : Elle est le plus souvent unilatérale, Le point de départ est souvent d'origine dentaire, Une cacosmie est souvent associée, Le scanner du massif facial peut montrer un aspect de « balle » calcique

Question 42

Terminé

Noté sur 1,00

Quels sont les germes rencontrés dans les otites moyennes aiguës chez l'enfant ? :

- a. *Haemophilus influenzae*
- b. *Streptocoque pneumoniae*
- c. *Branhamella catarrhalis*
- d. *Streptocoque A*
- e. *Staphylocoque aureus*

Les réponses correctes sont : *Haemophilus influenzae*, *Streptocoque pneumoniae*, *Branhamella catarrhalis*, *Staphylocoque aureus*



Question 43

Terminé

Noté sur 1,00

Une hypertension artérielle grade II a été diagnostiquée chez Mr A.B âgé de 54 ans, aux antécédents d'infarctus de myocarde.

Quel (s) traitement(s) pouvez-prescrire pour son HTA en 1ère intention ?

- a. Une monothérapie par un Bétabloquant
- b. Une monothérapie par un inhibiteur calcique
- c. Une bithérapie associant un bêta-bloquant et un inhibiteur de l'enzyme de conversion
- d. Une bithérapie associant un diurétique thiazidique et une spironolactone
- e. Une bithérapie associant un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un diurétique thiazidique

Les réponses correctes sont : Une bithérapie associant un bêta-bloquant et un inhibiteur de l'enzyme de conversion, Une bithérapie associant un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un diurétique thiazidique

Question 44

Terminé

Noté sur 1,00

Concernant l'évolution des hépatites aiguës virales vers la chronicité :

- a. L'hépatite aiguë A n'évolue jamais vers la chronicité
- b. L'hépatite aiguë E n'évolue vers la chronicité que chez les immunodéprimés
- c. L'hépatite aiguë B passe à la chronicité dans 80% des cas
- d. L'hépatite aiguë C évolue vers la chronicité dans 10% des cas
- e. L'hépatite aiguë D évolue plus vers la chronicité en cas de surinfection aiguë qu'en cas de coinfection aiguë

Les réponses correctes sont : L'hépatite aiguë A n'évolue jamais vers la chronicité, L'hépatite aiguë E n'évolue vers la chronicité que chez les immunodéprimés, L'hépatite aiguë D évolue plus vers la chronicité en cas de surinfection aiguë qu'en cas de coinfection aiguë



Question 45

Terminé

Noté sur 1,00

Dans le traitement chirurgical de la grossesse extra utérine, la laparotomie est :

- a. La voie de référence
- b. Indiquée en cas d'un hématosalpinx de 6 cm
- c. Indiquée devant un état de choc grave
- d. Indiquée devant une obésité extrême
- e. Indiquée en cas d'une insuffisance cardiaque décompensée

Les réponses correctes sont : Indiquée devant un état de choc grave, Indiquée devant une obésité extrême, Indiquée en cas d'une insuffisance cardiaque décompensée

Question 46

Terminé

Noté sur 1,00

La Tunisie est un pays de :

- a. Forte endémicité pour l'hépatite A
- b. Forte endémicité pour Le VHE
- c. Faible endémicité pour le VHB
- d. Faible endémicité pour le VHD
- e. Faible endémicité pour le VHC

Les réponses correctes sont : Faible endémicité pour le VHB, Faible endémicité pour le VHD, Faible endémicité pour le VHC

Question 47

Terminé

Noté sur 1,00

L'examen de certitude devant une GEU avant rupture est :

- a. L'échographie
- b. La coelioscopie
- c. La cordocentèse
- d. Abdomen sans préparation
- e. TDM abdominale

La réponse correcte est : La coelioscopie



Question 48

Terminé

Noté sur 1,00

Parmi les germes suivants, quels sont ceux qui sont fréquemment responsables d'exacerbation aigue de BPCO ?

- a. Pseudomonas Aeroginosa
- b. streptocoque alpha hémolytique
- c. Hémophilus influenzae
- d. Klebsiella pneumonia
- e. Branahmella cattarhalis

Les réponses correctes sont : Hémophilus influenzae, Branahmella cattarhalis

Question 49

Terminé

Noté sur 1,00

Quelles sont les caractéristiques des endocardites bactériennes aiguës tricuspidiennes ? :

- a. Fréquente chez les héroïnomanes
- b. Staphylocoque souvent responsable
- c. Survient chez des patients présentant des antécédents de rhumatisme articulaire aigue
- d. Embolies pulmonaires septiques fréquentes
- e. Traitement chirurgical toujours nécessaire

Les réponses correctes sont : Fréquente chez les héroïnomanes, Staphylocoque souvent responsable, Embolies pulmonaires septiques fréquentes

Question 50

Terminé

Noté sur 1,00

Les étiologies à évoquer devant une diarrhée chronique d'allure motrice associée à un flush syndrome :

- a. Les tumeurs carcinoïdes
- b. Syndrome de l'intestin irritable
- c. diabète
- d. Le cancer médullaire de la thyroïde
- e. Une hyperthyroïdie

Les réponses correctes sont : Syndrome de l'intestin irritable, diabète, Le cancer médullaire de la thyroïde, Une hyperthyroïdie



Question 51

Terminé

Noté sur 1,00

La BPCO, est caractérisée par :

- a. Une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes
- b. Un collapsus inspiratoire des voies aériennes
- c. Une augmentation du rapport VEMS1/CVL
- d. Une augmentation de la capacité vitale forcée
- e. Un effet shunt

Les réponses correctes sont : Une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes, Un effet shunt

Question 52

Terminé

Noté sur 1,00

Parmi les mesures non pharmacologiques suivantes, quelles sont celles qui sont indiquées dans le traitement de fond d'un patient BPCO groupe B ? :

- a. Sevrage tabagique
- b. Réhabilitation respiratoire
- c. Vaccination antigrippale annuelle
- d. Vaccination anti pneumococcique annuelle
- e. Activité physique quotidienne

Les réponses correctes sont : Sevrage tabagique, Réhabilitation respiratoire, Vaccination antigrippale annuelle, Activité physique quotidienne



Question 53

Terminé

Noté sur 1,00

Chez un patient âgé de 82 ans, ayant eu il y a un mois une prothèse de la hanche et qui présente une HTA de découverte récente (PA=165/75mmHg) vous prescrivez :

- a. Des règles hygiéno-diététiques seulement
- b. Une monothérapie par inhibiteur de l'enzyme de conversion
- c. Une monothérapie par inhibiteur calcique
- d. Une bithérapie associant un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un diurétique thiazidique
- e. Une bithérapie associant un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un Inhibiteur calcique

Les réponses correctes sont : Une monothérapie par inhibiteur de l'enzyme de conversion, Une monothérapie par inhibiteur calcique

Question 54

Terminé

Noté sur 1,00

L'hypertension artérielle :

- a. Est définie par une pression artérielle $\geq 140/90$ mmHg au cabinet médical
- b. Est définie par une pression artérielle $\geq 130/80$ mmHg à l'automesure
- c. Indique la réalisation d'un fond d'œil lorsqu'elle est de grade 3
- d. Est le plus souvent d'origine secondaire
- e. Est de grade 3 lorsque la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg et/ou la pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg

Les réponses correctes sont : Est définie par une pression artérielle $\geq 140/90$ mmHg au cabinet médical, Indique la réalisation d'un fond d'œil lorsqu'elle est de grade 3, Est de grade 3 lorsque la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg et/ou la pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg



Question 55

Terminé

Noté sur 1,00

Au cours du traitement du fond, la chambre d'inhalation avec embout buccal :

- a. Est indiquée chez l'enfant d'âge préscolaire
- b. Evite l'arrivée du médicament au niveau des bronches
- c. Diminue le passage systémique du médicament
- d. Peut être indiquée chez le sujet âgé
- e. Est indiquée avec les aérosols doseurs

Les réponses correctes sont : Diminue le passage systémique du médicament, Peut être indiquée chez le sujet âgé, Est indiquée avec les aérosols doseurs

Question 56

Terminé

Noté sur 1,00

Quel(s) est (sont) parmi ces facteurs de risque, celui ou ceux prédisposant à un asthme aigu grave :

- a. Adolescent asthmatique
- b. Augmentation de la fréquence des crises
- c. Réveils nocturnes < 1 fois/mois
- d. Besoins en bêta2mimétiques < 2 bouffées/semaine
- e. Antécédent d'hospitalisation en réanimation

Les réponses correctes sont : Adolescent asthmatique, Augmentation de la fréquence des crises, Antécédent d'hospitalisation en réanimation



Question 57

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Mr A, âgé de 67 ans, consulte pour des douleurs abdominales vagues avec vomissements et arrêt des matières et des gaz évoluant depuis deux jours.

A l'examen : Fébrile à 39°C, Abdomen distendu sensible dans sa totalité

Biologie : GB 20 400 é/mm³ CRP 200 mg/l

Urée 3 mmol/l Créatinine 34 µmol/l

1/ Quels sont les diagnostics à évoquer :

- a. Tumeur du grêle en occlusion
- b. Appendicite aigue méso coeliaque
- c. Cholécystite aigue
- d. Coliques néphrétiques hyper algiques
- e. Pyélo néphrite aigue

Les réponses correctes sont : Appendicite aigue méso coeliaque, Cholécystite aigue, Pyélo néphrite aigue

Question 58

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Quel est le premier examen à demander :

- a. Echographie abdominale
- b. TDM abdominale
- c. Radiographie du thorax centrée sur les coupes
- d. IRM abdominale
- e. Une urographie intra veineuse (UIV)

La réponse correcte est : TDM abdominale



Question 59

Terminé

Noté sur 1,00

3/ L'examen demandé montre une distension diffuse du grêle et du colon avec la présence d'une structure borgne en inter anse épaissie et épanchement de faible abondance en regard.

Quel diagnostic vous retenez ?

- a. Tumeur du grêle en occlusion
- b. Appendicite aigue méso coeliaque
- c. Cholécystite aigue
- d. Coliques néphrétiques hyper algiques
- e. Pyélo néphrite aigue

La réponse correcte est : Appendicite aigue méso coeliaque

Question 60

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Mm XY. est âgé de 67 ans, droitier, aux antécédents personnels d'hypertension artérielle et de diabète depuis 10 ans.

Il a présenté brutalement, à 07 heures du matin, une lourdeur du membre inferieur droit.

Il a consulté les urgences à 9heures du matin.

L'examen a objectivé une TA 180/100 mmHg, une température à 37°C ; une hémiplégie à prédominance crurale droite.

La glycémie au doigt était à 1,4 gramme/l.

La TDM cérébrale réalisée à 10H00 était normale

Le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique a été retenu.

1/ Quel est le territoire vasculaire touché ? :

- a. Le territoire de l'artère choroïdienne antérieure gauche
- b. Le territoire total de l'artère cérébrale moyenne gauche
- c. Le territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne gauche
- d. Le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche
- e. Le territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche

La réponse correcte est : Le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche



Question 61

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Quelle est la conduite thérapeutique dans l'immédiat ? :

- a. La prescription d'insuline rapide
- b. Baisser la Tension artérielle
- c. La perfusion de sérum glucosé
- d. La prescription de Mannitol
- e. La thrombolyse intraveineuse

La réponse correcte est : La thrombolyse intraveineuse

Question 62

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quels sont les examens complémentaires à demander dans le cadre du bilan étiologique en première intention? :

- a. NFS
- b. Bilan de thrombophilie
- c. Bilan lipidique
- d. Échographie trans œsophagienne
- e. ECG

Les réponses correctes sont : NFS, Bilan lipidique, ECG



Question 63

Terminé

Noté sur 1,00

Cas Clinique

Patiente âgée de 54 ans mère de 5 enfants consulte pour des métrorragies post coïtale

Antécédents : mariée à l'âge de 16 ans, diabétique, hypertendue

Sœur suivie pour un cancer du sein

1/ Identifier les éléments anamnestiques en faveur d'un cancer du col chez cette patiente :

- a. Multiparité
- b. Rapport sexuel précoce
- c. Diabétique
- d. Hypertendue
- e. Sœur suivie pour un cancer du sein

Les réponses correctes sont : Multiparité, Rapport sexuel précoce

Question 64

Terminé

Noté sur 1,00

2/ L'examen gynécologique trouve au spéculum une masse ulcéro-bourgeonnante qui saigne au contacte.

Cette masse mesure 4cm aux touchers pelviens.

Comment confirmer le diagnostic du cancer du col chez cette patiente ?

- a. IRM lombopelvienne
- b. Biopsie du col utérin
- c. Scanner thoraco-abdomino-pelvien
- d. Frottis cervico vaginal
- e. Pet scanner

La réponse correcte est : Biopsie du col utérin



Question 65

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Cette dame a un cancer épidermoïde du col utérin. L'examen ne trouve aucune autre anomalie
Quel bilan d'extension locorégional radiologique proposez-vous ?

- a. Scanner Abdomino-pelvien
- b. Echographie abdomino-pelvienne
- c. IRM lombopelvienne
- d. Cystoscopie
- e. Rectoscopie

La réponse correcte est : IRM lombopelvienne

Question 66

Terminé

Noté sur 1,00

Cas Clinique

Patiente âgée de 55 ans consulte pour un nodule du sein gauche évoluant depuis 6 mois.

L'interrogatoire note qu'elle est ménarche à l'âge de de 10 ans, patiente non encore ménopausée.

Elle est diabétique, hypertendue.

Elle a une sœur suivie pour un cancer du col utérin.

1/ Identifier les facteurs de risque en faveur d'un cancer du sein :

- a. Ménarche précoce
- b. Ménopause tardive
- c. Sœur suivie pour un cancer du col
- d. Diabétique
- e. Hypertendue

Les réponses correctes sont : Ménarche précoce, Ménopause tardive



Question 67

Terminé

Noté sur 1,00

2/ L'examen de la patiente trouve un nodule du sein gauche au niveau du quadrant supéro-externe mal limité, dur de 25 mm.

Pas d'adénopathie axillaire palpable.

L'examen du sein droit est normal.

Le reste de l'examen est sans particularité.

Quel(s) examen (s) complémentaire (s) radiologique(s) demandez-vous en première intention

- a. Le couple Mammographie et échographie mammaire
- b. IRM mammaire
- c. Mammographie
- d. Echographie mammaire
- e. Angiomammographie

La réponse correcte est : Le couple Mammographie et échographie mammaire

Question 68

Terminé

Noté sur 1,00

3/ La biopsie de cette lésion a confirmé le diagnostic d'un carcinome canalaire infiltrant SBR II, RH+ : RE=80%, RP= 90%, KI67= 40%, HEUR2neu négatif.

Le bilan d'extension est négatif.

Quel traitement chirurgical proposez-vous à cette patiente ?

- a. Tumorectomie avec un curage axillaire
- b. Mammectomie avec un curage axillaire
- c. Tumorectomie avec ganglion sentinelle
- d. Mammectomie avec ganglion sentinelle
- e. Mammectomie

La réponse correcte est : Tumorectomie avec ganglion sentinelle



Question 69

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un patient âgé de 55 ans consulte pour des épistaxis droites récidivantes depuis 6 mois, associées à des douleurs osseuses au niveau du bras droit.

L'endoscopie nasale trouve une tumeur bourgeonnante occupant la totalité du cavum et dont la biopsie confirme le diagnostic de carcinome du cavum de

type UCNT. L'examen TDM du cavum et cervical, associé à une IRM trouve une masse du cavum étendue à l'espace parapharyngé droit ainsi qu'une adénopathie

retropharyngée de 2.5 cm. La TDM thoraco-abdominale est normale.

La radiographie du bras est sans anomalies

1/ Cette tumeur est classée selon la classification TNM :

- a. T1N1Mx
- b. T1N0M0
- c. T2N1Mx
- d. T3N1M0
- e. T2N2M0

La réponse correcte est : T2N1Mx

Question 70

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Le bilan pré-thérapeutique doit comporter (une ou plusieurs réponses) ? :

- a. Une sérologie EBV
- b. Un PET SCAN au FDG
- c. Un examen stomatologique avec mise en état dentaire et préparation de gouttières porte gel fluoré
- d. %25Une scintigraphie osseuse
- e. Une échographie cardiaque

Les réponses correctes sont : Une sérologie EBV, Un examen stomatologique avec mise en état dentaire et préparation de gouttières porte gel fluoré, Une échographie cardiaque



Question 71

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Le bilan d'extension à distance étant sans anomalies, quel traitement préconisez-vous ? :

- a. Radio-chimiothérapie concomitante
- b. Radiothérapie externe exclusive incluant les aires ganglionnaires
- c. Chimiothérapie exclusive
- d. Chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une Radio-chimiothérapie concomitante
- e. Radiothérapie externe exclusive du cavum

La réponse correcte est : Radio-chimiothérapie concomitante

Question 72

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique : Patiente âgée de 35 ans, sans antécédents, se plaint depuis 1 semaine, de sensations de décharges électriques très intenses, brèves durant quelques secondes à 2 min, pluriquotidiennes touchant l'hémiface gauche. L'examen neurologique montre une hypoesthésie dans le territoire du V1 et V2 gauches.

1/ Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) à évoquer chez cette patiente :

- a. Céphalées de tension
- b. Migraine avec aura
- c. Algie vasculaire de la face
- d. Hypertension intracrânienne
- e. Névralgie du Trijumeau secondaire

La réponse correcte est : Névralgie du Trijumeau secondaire



Question 73

Terminé

Noté sur 1,00

2/Quels sont les arguments en faveur de votre diagnostic :

- a. Le sexe féminin
- b. La présence d'une zone gâchette
- c. Des anomalies à l'examen clinique
- d. L'absence de rémission entre les crises
- e. La durée des décharges

Les réponses correctes sont : Le sexe féminin, Des anomalies à l'examen clinique, L'absence de rémission entre les crises, La durée des décharges

Question 74

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quels sont les examens complémentaires à demander dans ce cas :

- a. Ponction lombaire
- b. Bilan biologique
- c. IRM cérébrale
- d. Biopsie des artères temporales
- e. Aucun examen ne sera demandé

La réponse correcte est : IRM cérébrale



Question 75

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Patiente âgée de 41 ans, ayant 3 enfants accouchés par césarienne vous consulte pour désir de contraception.

Elle est Tabagique à 10 paquets-année, et présente une hyperthyroïdie sous antithyroïdiens de synthèse.

Sa dernière césarienne s'est compliquée d'une thrombose veineuse profonde.

1/ Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent une contre-indication absolue à la pilule oestroprogestative ?

- a. L'âge
- b. L'utérus tri-cicatriciel
- c. L'antécédent d'un accident thrombo-embolique
- d. L'hyperthyroïdie
- e. La multiparité

Les réponses correctes sont : L'âge, L'antécédent d'un accident thrombo-embolique

Question 76

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Sachant que la patiente refuse la prise quotidienne d'une contraception orale, quelles sont les options que vous pouvez lui proposer parmi les propositions suivantes ?

- a. L'implant sous-cutané
- b. L'anneau vaginal oestro-progestatif
- c. Le patch cutané oestro-progestatif
- d. Le macro-progestatif injectable
- e. Le dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel

Les réponses correctes sont : L'implant sous-cutané, Le macro-progestatif injectable, Le dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel



Question 77

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Vous avez opté pour un DIU au cuivre. Quelles sont les précautions à prendre en considération avant sa pose ?

- a. Vérifier la date des dernières règles
- b. Choisir un modèle adapté à la morphologie de l'utérus
- c. Vérifier l'absence de troubles de la crase sanguine
- d. Faire un prélèvement vaginal systématiquement
- e. Faire un dosage des β HCG

Les réponses correctes sont : Vérifier la date des dernières règles, Choisir un modèle adapté à la morphologie de l'utérus, Vérifier l'absence de troubles de la crase sanguine

Question 78

Terminé

Noté sur 1,00

4/ Quelles sont les complications possibles après la pose du DIU ?

- a. La prise de poids
- b. L'infection urinaire
- c. L'expulsion
- d. La perforation
- e. La grossesse extra-utérine

Les réponses correctes sont : L'expulsion, La perforation, La grossesse extra-utérine



Question 79

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques notables, se présente aux urgences pour une douleur thoracique évoluant depuis deux jours, aggravée par le décubitus dorsal et la toux et partiellement améliorée par la prise de trinitrine.

A l'examen :

Température = 37,9° C, la fréquence cardiaque était à 90 bpm régulière, sa pression artérielle était 120/70 mmHg, les bruits du cœur étaient assourdis et il n'avait pas de signes d'insuffisance cardiaque.

A l'ECG : Rythme régulier sinusal, microvoltage diffus, pas de troubles de la repolarisation

A la biologie : GB= 15000 e/mm³, Hb= 13 g/dl, Plaquettes= 400000 e/mm³

CRP= 30 mg/l Créatinine sanguine= 90 umol/l

1/ Devant ce tableau, quel(s) diagnostic(s) est (sont) évoqué(s) en premier :

- a. Une péricardite aiguë
- b. Une tamponnade cardiaque
- c. Une embolie pulmonaire
- d. Un syndrome coronarien aigu
- e. Une dissection de l'aorte

La réponse correcte est : Une péricardite aiguë

Question 80

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Parmi ces examens complémentaires, le(s)quel(s) est (sont) indiqué(s) en 1ère intention pour confirmer le diagnostic :

- a. Une échocardiographie transthoracique
- b. Une échocardiographie transoesophagienne
- c. Un coroscanner
- d. Le dosage des BNP
- e. Le dosage des D-Dimères

La réponse correcte est : Une échocardiographie transthoracique



Question 81

Terminé

Noté sur 1,00

3/Quel(s) est (sont) le(s) élément(s) de gravité chez ce patient :

- a. L'âge jeune
- b. La tempéraure à 37,9° C
- c. L'assourdissement des bruits du cœur à l'auscultation cardiaque
- d. Le microvoltage diffus à l'ECG
- e. Le syndrome inflammatoire biologique

Les réponses correctes sont : L'assourdissement des bruits du cœur à l'auscultation cardiaque, Le microvoltage diffus à l'ECG

Question 82

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Une fille âgée de 17 ans sans antécédents familiaux consulte suite à la survenue d'une crise épileptique tonico-clonique généralisée. A l'interrogatoire, on trouve la notion de secousses myocloniques survenant peu après le réveil avec parfois un lâchage des objets depuis l'âge de 12 ans.

Vous suspectez une épilepsie myoclonique juvénile.

1/ Les arguments en faveur de l'épilepsie myoclonique juvénile sont :

- a. Le sexe féminin
- b. Le début à l'adolescence
- c. L'absence d'antécédents familiaux
- d. Les myoclonies matinales
- e. La survenue de crises tonico-cloniques généralisées

Les réponses correctes sont : Le début à l'adolescence, Les myoclonies matinales, La survenue de crises tonico-cloniques généralisées



Question 83

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Les crises myocloniques dans le cadre de l'épilepsie myoclonique juvénile peuvent être favorisées par :

- a. Le manque de sommeil
- b. L'hyperventilation
- c. L'exposition à une stimulation lumineuse intermittente
- d. Les réveils brusques
- e. Le stress

Les réponses correctes sont : Le manque de sommeil, L'exposition à une stimulation lumineuse intermittente, Les réveils brusques

Question 84

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Vous demandez pour cette patiente un électroencéphalogramme (EEG).

Les anomalies observées à l'EEG intercritique sont:

- a. Des polypointe-ondes généralisées
- b. Des décharges de pointes ondes à 3 Hz
- c. Des pointe-ondes asynchrones, diffuses et permanentes
- d. Des pointes centro-temporales lentes biphasiques
- e. Des ondes lentes focales

La réponse correcte est : Des polypointe-ondes généralisées



Question 85

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique

Un patient âgé de 65 ans, asthmatique mal équilibré, porteur d'une cirrhose post hépatite C consulte pour une hémorragie digestive extériorisée sous forme de mélénas.

L'examen trouve une TA à 100/60 mmHg, une fréquence cardiaque à 90 bpmn, une hépatomégalie avec flèche hépatique à 14 cm et un bord inférieur du foie dur, une matité déclive des flancs, une circulation veineuse collatérale, splénomégalie à quatre travers de doigt et le toucher rectal confirme les mélénas.

A la biologie : GS O positif, Hb : 7.1 g/dl, Ht 21%, Plaquettes : 110000 éltts/mm³

TP : 60 %, urée : 5 mmol/l

La FOGD faite en urgence montre des varices oesophagiennes avec signes rouges.

1/ Quel est la cause de la circulation veineuse collatérale au niveau de la paroi abdominale ?

- a. L'insuffisance hépatocellulaire secondaire à la cirrhose
- b. Le shunt veineux entre le système porte et le système azygos
- c. Le shunt veineux entre les veines para-ombilicales et les veines épigastriques
- d. Un obstacle au retour veineux sur la veine cave supérieure
- e. Un gradient de pression porto-cave > 5 mm Hg

Les réponses correctes sont : Le shunt veineux entre les veines para-ombilicales et les veines épigastriques, Un gradient de pression porto-cave > 5 mm Hg

Question 86

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Quel est votre conduite à tenir thérapeutique ?

- a. Transfusion par deux culots globulaires O positif
- b. Antibiothérapie par de la norfloxacine seulement en cas de surinfection du liquide d'ascite
- c. Mise en place d'une sonde de Blackmore
- d. Sandostatine 25µg/h à la pousse seringue électrique
- e. TIPS en urgence

La réponse correcte est : Sandostatine 25µg/h à la pousse seringue électrique



Question 87

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Une fois cet épisode hémorragique jugulé.

Comment assurez-vous la prévention secondaire ?

~%-100%TIPS}

- a. Traitement par B bloquants
- b. Ligature élastiques des varices
- c. Traitement chirurgical par transsection œsophagienne
- d. Injection de colle biologique

La réponse correcte est : Ligature élastiques des varices

Question 88

Terminé

Noté sur 1,00

	24H	Diurne	Nocturne
PAS moyenne	117mmHg	124mmHg	103mmHg
PAD moyenne	71mmHg	76mmHg	60mmHg

Dipping : 17%

Cas clinique : Madame Bahija

âgée de 69 ans, diabétique type 2, HTA depuis 10 ans sous trithérapie : ramipril 10mg+ amlodipine 10 mg + hydrochlorothiazide 25 mg. Au cours de son dernier contrôle : patiente asymptomatique, sa TA au cabinet=160/90 mmHg, FC=80/min, l'auscultation cardio-pulmonaire est sans anomalies. ECG:RRS à 70/min, indice de sokolow à 44mm Biologie : créatinine à 65 umol/l, microalbuminurie à 35mg/24h Voici les résultats de la MAPA demandée pour suspicion d'HTA résistante. 1/ Selon les données clinico-biologiques, électriques et de la MAPA, Madame Bahija :

- a. A une HTA masquée
- b. A une HTA contrôlée
- c. A une HTA grade 3
- d. Est dipper
- e. A une HTA avec atteinte d'organes cibles

Les réponses correctes sont : A une HTA contrôlée, Est dipper, A une HTA avec atteinte d'organes cibles



Question 89

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Comment évaluez vous le risque cardio-vasculaire de madame Bahija ?

- a. Faible
- b. Modéré
- c. Elevé
- d. Très élevé
- e. D'autres données sont nécessaires pour pouvoir évaluer son risque cardio-vasculaire

La réponse correcte est : Très élevé

Question 90

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quelle sera votre conduite à tenir thérapeutique ?

- a. Rajouter une spironolactone
- b. Rajouter un Béta-bloquant
- c. Rajouter un alpha-bloquant
- d. Modifier le ramipril par valsartan
- e. Maintenir le même traitement

La réponse correcte est : Maintenir le même traitement



Question 91

Terminé

Noté sur 1,00

Patiente, âgée de 40 ans, consulte pour des douleurs intermittentes au niveau de l'hypochondre droit évoluant depuis 30 jours.

A l'anamnèse, la patiente est originaire de Tatatouine et réside à Kasserine, femme au foyer, possède un chat et consomme souvent des grillades d'agneaux abattus dans la ferme de ses parents.

A l'examen, la patiente est apyrétique, présentant un ictère conjonctival, un abdomen souple et une flèche hépatique à 15 cm.

A la biologie, l'hémogramme est normal. Au bilan hépatique, on note une élévation de la bilirubine à prédominance conjuguée, des phosphatases alcalines et des gamma GT.

Un kyste hydatique du foie compliqué est évoqué.

1/ Les éléments de l'observation en faveur de ce diagnostic sont :

- a. L'hépatomégalie
- b. La possession d'un chat
- c. La consommation de grillade
- d. L'origine géographique
- e. L'habitat à Kasserine

Les réponses correctes sont : L'hépatomégalie, L'origine géographique, L'habitat à Kasserine

Question 92

Terminé

Noté sur 1,00

2/ La complication à suspecter devant ce tableau est :

- a. Surinfection du kyste
- b. Compression des veines sus-hépatiques
- c. Rupture du kyste dans les voies biliaires
- d. Compression des voies biliaires hépatiques
- e. Echinococcose secondaire

La réponse correcte est : Compression des voies biliaires hépatiques



Question 93

Terminé

Noté sur 1,00

3/ La confirmation du diagnostic repose sur :

- a. La sérologie hydatique
- b. L'échographie abdominale
- c. La ponction du foie
- d. L'examen parasitologique des selles
- e. La recherche de copro-antigènes

Les réponses correctes sont : La sérologie hydatique, L'échographie abdominale

Question 94

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme âgé de 42 ans, transplanté rénal sous traitement immunosuppresseur, présente depuis 3 jours une toux sèche quinteuse associée à un catarrhe nasal, une odynophagie et des brûlures rétro-sternales dans un contexte d'une fébricule.

Il a pris par automédication un antitussif et un antipyrétique.

Depuis 24 heures, il présente des douleurs basithoraciques droites à type de point de côté avec des frissons intenses et une asthénie marquée.

A l'examen, il a une température à 39,5°C, une fréquence respiratoire à 32c/mn, une saturation périphérique en oxygène à 95% à l'air ambiant et une fréquence cardiaque à 125 bpm.

Le diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire est évoqué chez ce patient.

1/ Quels sont les symptômes en faveur de ce diagnostic chez ce patient ?

- a. Toux sèche quinteuse
- b. Frissons et asthénie
- c. Fièvre à 39,5°C
- d. Douleurs thoraciques en point de côté
- e. Catarrhe nasal

Les réponses correctes sont : Frissons et asthénie, Fièvre à 39,5°C, Douleurs thoraciques en point de côté



Question 95

Terminé

Noté sur 1,00

2/ L'hospitalisation de ce patient est indiquée devant :

- a. La fièvre à 39,5°C
- b. Le terrain immunodéprimé
- c. L'âge à 42 ans
- d. La fréquence respiratoire à 32c/mn
- e. La saturation périphérique en oxygène à 95%

Les réponses correctes sont : Le terrain immunodéprimé, La fréquence respiratoire à 32c/mn

Question 96

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quelle antibiothérapie prescrivez-vous chez ce patient ?

- a. Levofloxacin
- b. Clarithromycine
- c. Pristinamycine
- d. Amoxicilline-acide clavulanique
- e. Métronidazole

La réponse correcte est : Amoxicilline-acide clavulanique



Question 97

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme de 55 ans présente depuis 3mois des rectorragies, accompagnées de ténesme et de faux besoins. Son état général est conservé. Le toucher rectal est normal. L'examen de l'abdomen ne montre pas de masse palpable.

Une rectosigmoïdoscopie montre une lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, sur la face antérieure du rectum,

à 12 cm de la marge anale, de 3 cm de diamètre. Des biopsies sont pratiquées au niveau de cette lésion.

1/ Quel est le résultat anatomopathologique le plus probable de cette biopsie ? :

- a. Polype adénovilleux
- b. Adénocarcinome Lieberkühnien
- c. Adénocarcinome colloïde muqueux
- d. Carcinome malpighien
- e. Sarcome

La réponse correcte est : Adénocarcinome Lieberkühnien

Question 98

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Le bilan préopératoire de ce malade comportera :

- a. Une coloscopie totale
- b. Un dosage antigènes carcino embryonnaires
- c. Une échographie hépatique
- d. Une fibroscopie oeso-gastrique
- e. Une artériographie mésentérique inférieure

Les réponses correctes sont : Une coloscopie totale, Un dosage antigènes carcino embryonnaires, Une échographie hépatique



Question 99

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quel traitement envisagez-vous :

- a. Amputation abdomino-périnéale
- b. Résection antérieure du rectum
- c. Chirurgie limitée par rectotomie
- d. Intervention de Hartman
- e. Radiothérapie de contact

La réponse correcte est : Résection antérieure du rectum

Question 100

Terminé

Noté sur 1,00

4/ La surveillance ultérieure de ce patient comportera systématiquement :

- a. Coloscopie de contrôle
- b. Scanner pelvien
- c. Echographie hépatique
- d. Dosage de l'Alpha foeto-protéine
- e. Dosage de l'antigène carcino-embryonnaire

Les réponses correctes sont : Coloscopie de contrôle, Echographie hépatique, Dosage de l'antigène carcino-embryonnaire



Question 101

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme âgé de 62 ans consulte pour un œdème unilatéral du membre inférieur droit inflammatoire avec signe de Homans positif.

Le diagnostic de thrombose veineuse profonde est suspecté.

1/ Quel(s) examen(s) complémentaire(s) permet(tent) de confirmer le diagnostic de TVP ?

- a. TDM thoracique
- b. Angio-TDM thoracique
- c. Echographie doppler veineux des membres inférieurs
- d. D-Dimères
- e. Echographie cardiaque

La réponse correcte est : Echographie doppler veineux des membres inférieurs

Question 102

Terminé

Noté sur 1,00

2/ Le diagnostic de thrombose veineuse profonde a été retenu. A la biologie, on note une insuffisance rénale avec une clairance de la créatinine à 20ml/mn.

Quel(s) traitement(s) proposez-vous pour ce patient à la phase aigue :

- a. Antivitamine K
- b. Héparine bas poids moléculaire
- c. Héparine Sodique
- d. Héparine calcique
- e. Aspirine

Les réponses correctes sont : Héparine Sodique, Héparine calcique



Question 103

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quel(s) bilan(s) biologique est (sont) nécessaire dans le suivi de ce traitement :

- a. NFS
- b. TP
- c. Créatinine
- d. TCA
- e. INR

Les réponses correctes sont : NFS, TCA

Question 104

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Une patiente âgée de 39 ans, infirmière, aux antécédents d'hépatite virale B chronique suivie, mère d'un enfant de 4 ans, consulte pour des crachats hémoptoïques récidivants de faible abondance. A l'examen physique : Poids = 61 kg, une fièvre à 38,3 Auscultation pulmonaire normale.

Sa radiographie du thorax a montré des opacités micronodulaires apicales gauches. Les recherches de BK dans les crachats sont positives à 2 croix.

Le bilan pré-thérapeutique est normal.

1/ Quel sera le traitement anti-tuberculeux à indiquer chez cette patiente :

- a. INH (200 mg/j) + Rifampicine (600 mg/j)+ Ethambutol (1400 mg/j)+ Pyrazinamide (2000 mg/j)
- b. INH (200 mg/j) + Rifampicine (600 mg/j) + Ethambutol (1400 mg/j)
- c. INH (200 mg/j) + Rifampicine (600 mg/j)
- d. HRZE : 4 comprimés/jour
- e. HR : 4 comprimés/jour

La réponse correcte est : INH (200 mg/j) + Rifampicine (600 mg/j) + Ethambutol (1400 mg/j)



Question 105

Terminé

Noté sur 1,00

2/ La durée totale du traitement antituberculeux chez cette patiente est :

- a. 9 mois
- b. 10 mois
- c. 8 mois
- d. 12 mois
- e. 6 mois

La réponse correcte est : 9 mois

Question 106

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Quelle sera votre conduite à tenir vis-à-vis de son enfant ?

- a. Aucune conduite
- b. Chimio-prophylaxie
- c. Un dépistage à la recherche de signes évocateurs de la tuberculose maladie
- d. Les tests IGRAs
- e. HRZ en fonction du poids

Les réponses correctes sont : Chimio-prophylaxie, Un dépistage à la recherche de signes évocateurs de la tuberculose maladie



Question 107

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Mme BM âgée de 64 ans, allergique à la pénicilline, coronarienne sous aspirine au long cours, consulte aux urgences pour une hémorragie digestive extériorisée sous forme de méléna.

Examen: pouls à 82 bpm/min, TA=12/7.

Biologie : Hb à 11 g/dl, pas d'insuffisance rénale

Après avoir entamé les mesures de réanimation, une fibroscopie oesogastro-duodénale (FOGD) est réalisée, montrant un ulcère de la face postérieure du bulbe de 10 mm le siège de taches pigmentées

1/ Selon la classification de Forrest, cet ulcère est classé :

- a. Forrest Ia
- b. Forrest Ib
- c. Forrest IIa
- d. Forrest IIb
- e. Forrest IIc

La réponse correcte est : Forrest IIc

Question 108

Terminé

Noté sur 1,00

2/ En plus des mesures de réanimation, quel (s) traitement (s) proposez-vous dans l'immédiat ?

- a. un traitement médical par inhibiteur de la pompe à proton (IPP) par voie intra-veineuse
- b. un traitement médical par inhibiteur de la pompe à proton (IPP) par voie orale
- c. Un traitement endoscopique de l'ulcère par injection d'adrénaline diluée
- d. un traitement endoscopique de l'ulcère par pose de clips métalliques
- e. un traitement chirurgical de l'ulcère

La réponse correcte est : un traitement médical par inhibiteur de la pompe à proton (IPP) par voie intra-veineuse



Question 109

Terminé

Noté sur 1,00

3/ Le traitement initial a permis de contrôler l'hémorragie active. Un traitement d'éradication anti *Helicobacter Pylori* (HP) suivi d'un traitement d'entretien ont été prescrits.

Quel traitement d'éradication anti-HP de première intention proposez-vous pour cette patiente ?

- a. Oméprazole 40mg/j pendant 7jours
- b. Quadrithérapie bismuthée pendant 10 jours
- c. Oméprazole 40mg/j + Amoxicilline 2g/j + Métronidazole 1g/j + Clarithromycine 1g/j pendant 14j
- d. Oméprazole 40mg/j + Métronidazole 1g/j + Clarithromycine 1g/j pendant 14j
- e. Oméprazole 40mg/j + Amoxicilline 2g/j + lévofloxacine 500mg/j pendant 14j

La réponse correcte est : Quadrithérapie bismuthée pendant 10 jours

Question 110

Terminé

Noté sur 1,00

4/ Un mois après la fin du traitement, la patiente est asymptomatique. Un contrôle de l'éradication est indiqué.

Quel moyen proposez-vous pour contrôler l'éradication de HP ?

- a. Un test rapide à l'uréase
- b. Une étude histologique des biopsies duodénales
- c. Un test respiratoire à l'urée marquée (Breath test)
- d. Une sérologie anti-HP
- e. Une mise en culture des biopsies gastriques

La réponse correcte est : Un test respiratoire à l'urée marquée (Breath test)



Question 111

Terminé

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un enfant, âgé de 5 ans et demi, est amené à vos consultations pour des douleurs abdominales récurrentes. A l'anamnèse, les parents vous rapportent que le début de la symptomatologie a coïncidé avec la rentrée scolaire (soit 2 mois avant la consultation).

Ces douleurs abdominales surviennent le matin, et sont accompagnées de nausées. Ces symptômes ont retenti sur son intégration scolaire avec un absentéisme fréquent.

Toutes les explorations faites sont revenues négatives. Une cause organique a été éliminée.

A l'entretien, vous retrouvez un enfant calme, collé à sa mère, qui vous rapporte difficilement, qu'il a peur de la maitresse à l'école.

1/A partir des données anamnestiques et cliniques, quels sont les éléments qui vous orientent vers un trouble anxiété de séparation ?

- a. Age de l'enfant
- b. La peur de la maitresse exprimée par l'enfant
- c. Durée d'évolution des troubles
- d. Attitude de l'enfant au cours de l'entretien
- e. La chronologie de la symptomatologie

Les réponses correctes sont : Age de l'enfant, Durée d'évolution des troubles, Attitude de l'enfant au cours de l'entretien, La chronologie de la symptomatologie

Question 112

Terminé

Noté sur 1,00

2/ La prise en charge de cet enfant repose sur :

- a. La prescription d'anxiolytiques
- b. La prescription d'antidépresseurs
- c. L'arrêt de la scolarité
- d. L'autonomisation de l'enfant
- e. Instauration d'une triangulation avec la séparation de la dyade mère enfant

Les réponses correctes sont : L'autonomisation de l'enfant, Instauration d'une triangulation avec la séparation de la dyade mère enfant

